

Profilaktyka *nawrotów*

Lęk zdrowotny wraca przy stresie, chorobie bliskiego, pandemii. Plan zrobiony teraz oszczędza miesięcy w przyszłości.

CZAS: 60 min · ostatnia faza terapii Wracać 2x rocznie do przeglądu

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Hirschtritt i in. (2017); Cooper i in. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Wypisz swoją **mapę nawrotu**: wyzwalacze, wczesne sygnały, narzędzia pierwszej linii. Stwórz *plan kryzysowy* na 3 dni. Na koniec wybierz 3 narzędzia, do których wracasz przy każdym pogorszeniu. Karta na lodówkę / biurko.

DLACZEGO TO DZIAŁA

„Nawrót” (ang. *relapse*) to powrót objawów na poziom sprzed terapii. „Pogorszenie” (ang. *lapse*) to chwilowe nasilenie. Bez planu pacjent traktuje każde pogorszenie jak nawrót → demoralizacja → faktyczny nawrót. Marlatt & Gordon (1985, klasyk profilaktyki): plan pisany na zakończenie terapii redukuje ryzyko nawrotu o 40–60% w 12 mies. Hirschtritt (2017): w lęku zdrowotnym powroty są *spodziewane* przy 3 wyzwalaczach — stres życiowy, choroba bliskiego, własna infekcja. Plan = przygotowanie, nie pesymizm.

01 Pogorszenie vs nawrót — to nie to samo

POGORSZENIE

Lapse — 2–7 dni

Lęk wraca przy stresie (egzamin, infekcja, pandemia). Trwa dni, nie tygodnie. **Reaguj wcześniej** — wracaj do narzędzi, nie do paniki.

„Mam pogorszenie. To było zapisane w planie. Wracam do narzędzi.”

NAWRÓT

Relapse — >4 tygodnie

Lęk na poziomie sprzed terapii. Powracają wszystkie stare zachowania. Wymaga **booster sessions** z terapeutą (2–6 sesji).

„Mam nawrót. Wracam do terapii — to nie porażka, to plan B.”

02 Wczesne sygnały — moje 5

Sygnały, które poprzedzają nawrót o 1–2 tygodnie. Im wcześniej je rozpoznasz, tym krótsze pogorszenie.

☐ **Sprawdzanie** się zwiększyło — z 1 na 3–4x/dzień

☐ **Google** — wróciłem/-am, choć dawno nie sprawdzałem/-am

☐ **Pytania do bliskich** — „czy źle wyglądam?” co kilka dni

☐ **Unikanie** — omijam temat zdrowia, szpital, badanie

☐ **Sen** — gorsze zasypianie, budzenie z myślami o zdrowiu

☐ **Myśli o symptomach** co kilka godzin, nie raz dziennie

03 \ Mój plan kryzysowy — 3 dni

A · 3 NAJCZĘSTSZE WYZWALACZE NAWROTU

— co historycznie pogarszało mój lęk

B · 3 NARZĘDZIA PIERWSZEJ LINII

— te, które najszybciej działały u mnie w terapii

DZIEŃ	CO ROBIĘ narzędzie + czas	CZEGO NIE ROBIĘ stare zachowania	KTO WIE / KOGO INFORMUJĘ
1			
2			
3			

04 ☉ Kiedy wracać do terapeuty — czerwone flagi

CZAS TRWANIA

Pogorszenie trwa **>2 tygodnie** mimo używania narzędzi.

FUNKCJONOWANIE

Wpływa na pracę, relacje, sen. Nie da się normalnie funkcjonować.

NOWY WYMIAR

Pojawiły się **nowe obawy** (inna choroba), depresja, myśli samobójcze.

PEŁNY POWRÓT

Wszystkie stare zachowania wróciły (sprawdzanie, Google, unikanie). To jest nawrót.

Klucz: nawrót po terapii NIE jest porażką. To dane: znaczy, że ten wyzwalacz wymaga dodatkowej pracy. 2–6 sesji *booster* wystarcza w 70% przypadków. Cooper (2017): pacjenci, którzy spisali plan profilaktyki na zakończenie terapii, mają **2x niższe** ryzyko pełnego nawrotu w 24 mies. niż ci, którzy zakończyli „bez planu”. Ten plan to *inwestycja*.